

## Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format 4.0

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

### I. Algemene informatie

#### 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: M JEUKEN

BIG-registraties: 69059832125

Overige kwalificaties: Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut

Basisopleiding: Universiteit Utrecht Psychologie Cognitieve Functiestoornissen

Persoonlijk e-mailadres: mjeuken@hotmail.com

AGB-code persoonlijk: 94013330

#### Praktijk informatie 1

Naam Praktijk of Handelsnaam: Praktijk voor psychotherapie Monique Jeuken

E-mailadres: info@moniquejeuken.nl

KvK nummer: 77453913

Website: <http://www.moniquejeuken.nl>

AGB-code praktijk: 94065647

#### 1b. Werkt u op meer dan één locatie, geef dan de locaties en adresgegevens hieronder in:

#### 2. Biedt zorg aan in

Er is sprake van een overgangssituatie daarbij we zowel werken met een onderscheid in generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz als een indeling naar settings van het Zorgprestatiemodel. In de toekomst zal het eerste onderscheid komen te vervallen.

##### 2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.  
de gespecialiseerde-ggz

##### 2b. Biedt zorg aan in setting 1 en vult de voorwaarden ten aanzien van de indicerende en coördinerende rol als volgt in:

Ik bespreek elk jaar een minimum aantal indicatiestellingen met collega's, ik word hierop elke vijf jaar getoetst tijdens de LVVP visitatie.

#### 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

##### 3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betreft u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Binnen de praktijk behandel ik cliënten van 18 jaar en ouder binnen de SGGZ. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angst-, dwang en stemmingsklachten, (complexe) traumagerelateerde problematiek, persoonlijkheidsproblematiek, (milde) eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Tijdens de intake bekijk ik samen met een cliënt welke klachten er spelen en welke behandeling het meest passend is bij deze klachten en bij de persoon. Toegepaste behandelvormen zijn met name

cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, EFT, ACT en (integratieve) psychotherapie in combinatie met eHealth. Ik vind het belangrijk het steunsysteem bij de behandeling te betrekken.

**3b. Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:**

Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn

Angststoornissen

Depressieve stemmingsstoornissen

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen

Trauma en stress gerelateerde stoornissen

Voedings- en eetstoornissen

**4. Samenstelling van de praktijk**

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

**Regiebehandelaar 1**

Naam: M. Jeuken

BIG-registratienummer: 69059832125

**5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk**

**5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:**

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

**5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):**

Huisartsen, POH-GGZ, studenten psycholoog van de Breda University of Applied Sciences (BUAS).

Dhr. P. Kok (GZ-psycholoog/Psychotherapeut, BIG registratie 94015663), mevr. M. Westbroek

(Klinisch psycholoog/Psychotherapeut, BIG registratie 29049176525) en mevr. C. van Dijk (Klinisch psycholoog, BIG registratie 29049645125)

**5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:**

Consultatie, intercollegiale toetsing, doorverwijzing, verwijzingen voor medicatieconsulten, intercollegiaal overleg, intervisie, vervanging bij vakantie en langdurige ziekte.

**5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, ggz-crisisdienst of voor fysieke aspecten huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp):**

In geval van crisis kunnen cliënten tijdens de openingstijden van de praktijk contact opnemen met mij en/of met de eigen huisartsenpraktijk. Binnen kantoor tijd, maar buiten de openingstijden van de praktijk kunnen cliënten contact opnemen met de eigen huisartsenpraktijk. 's Avonds, 's nachts of in het weekend kunnen cliënten -in geval van crisis- contact opnemen met de Huisartsenpost (HAP) in de betreffende regio.

**5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?**

Nee, omdat: ik op mijn website vermeld dat cliënten -in geval van crisis- tijdens de openingstijden van de praktijk contact met mij of de eigen huisartsenpraktijk, kunnen opnemen. Daarnaast vermeld ik op mijn website dat cliënten -binnen kantoor tijd, maar buiten de openingstijden van de praktijk, contact kunnen opnemen met de eigen huisartsenpraktijk. 's Avonds, 's nachts of in het weekend kunnen cliënten -in geval van crisis- contact opnemen met de Huisartsenpost (HAP) in hun regio. Daarnaast is de huisartsenpost in de regio goed te bereiken en goed in staat een inschatting te maken van wat nodig is.

**5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:**

Dhr. P. Kok, mevr. M. Westbroek, mevr. C. van Dijk en mevr. M. Jeuken

**5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:**

Er vinden intervisies plaats waarbij indicatiestelling, lopende behandelingen, stagnaties en eventuele crisissituaties besproken worden. Ook wordt de kennis van de sociale kaart GGZ van de regio gedeeld en worden er ontwikkelingen rondom het werken in een eigen praktijk besproken.

**6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg**

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

**Geef u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is**

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: <https://www.moniquejeuken.nl/kosten>

**7. Behandeltarieven:**

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

<http://www.moniquejeuken.nl/kosten>

**8. Kwaliteitswaarborg**

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

<https://lvvp.info/nieuwsbrief/update-kwaliteitscriteria-voor-de-vrijgevestigde-praktijk/>

**Organisatie van de zorg**

**9. Klachten- en geschillenregeling**

**Mijn cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):**

De klachtenregeling van de LVVP. De klachten- en geschillenregeling is hier te vinden:

<http://www.moniquejeuken.nl/kwaliteit>, alwaar ook een link geplaatst is naar de klachtenregeling van

de LVVP.

**Link naar website:**

<http://www.moniquejeuken.nl/kwaliteit>

**10. Regeling bij vakantie en calamiteiten**

**10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij**

Naam vervangend behandelaar:

Dhr. P. Kok, psychotherapeut

**10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:**

Ja

**II. Het zorgproces - het traject dat de cliënt in de praktijk doorloopt**

## **11. Wachtijd voor intake en behandeling**

Clënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: <http://www.moniquejeuken.nl/aanmelden>

## **12. Aanmelding en intake/probleemanalyse**

### **12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de cliënt):**

Clënten kunnen zichzelf aanmelden bij de praktijk of kunnen worden aangemeld door hun huisarts. Wanneer cliënten zichzelf aanmelden sturen zij een mail naar [info@moniquejeuken.nl](mailto:info@moniquejeuken.nl) of nemen telefonisch contact op. Bij aanmelding via mail of bij ingesproken voicemail neem ik telefonisch contact op met client ter bevestiging van de inschrijving. Daarbij wordt informatie gegeven over de meest recente wachttijden (ook te vinden op de website). Clënten worden vervolgens op de wachtlijst geplaatst en zodra er ruimte is, worden zij gebeld of gemaïld door mw. M. Jeuken voor het plannen van een afspraak voor intake. Clënten ontvangen daarna per mail een afspraakbevestiging, een aanmeldformulier met aanvullende gegevens, een informatiebrief over de praktijk en een link voor een ROM-vragenlijst. Clënten sturen voor het intakegesprek de verwijsbrief van de huisarts, het ingevulde aanmeldformulier, alsook het ingevulde toestemmingsformulier (waarop men kan invullen al dan niet akkoord te gaan met het uitwisselen van informatie met de verwijzer/huisarts) per post of per mail naar de praktijk toe. Wanneer cliënten door de huisarts worden aangemeld stuurt deze de verwijsbrief door via zorgmail of per post en vraagt tevens aan de cliënt zelf contact op te nemen met de praktijk om de aanmelding te bevestigen. Vanaf hier verloopt de procedure hetzelfde als hierboven beschreven.

De praktijk verwijst de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt.

### **12b. Ik verwijs de cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt:**

Ja

## **13. Behandeling en begeleiding**

### **13a. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de cliënt):**

Ja

### **13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicierend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:**

Ja

### **13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling en begeleiding. Ik doe dat als volgt:**

Aan het begin van de intakeprocedure wordt er mondelinge uitleg gegeven omtrent het intake-traject. Aan het einde van het intake-traject vindt er een adviesgesprek plaats waarin duidelijk wordt besproken wat de voorlopige conclusies en gestelde diagnoses zijn. Er wordt met cliënten besproken welke behandelopties er zijn en wordt, in overleg met cliënt, voor één van deze opties gekozen. Dit alles wordt vastgelegd in een behandelplan, wat zowel mondeling als schriftelijk door cliënt geaccordeerd wordt. Client ontvangt hiervan een exemplaar mee naar huis, de andere wordt opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier.

In een lopend behandeltraject wordt het behandelplan geregeld geëvalueerd; minimaal iedere zes maanden of eerder indien gewenst, waarna indien nodig aanpassing volgt.

**13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):**

Het behandelplan wordt minimaal iedere zes maanden of eerder indien gewenst mondeling met cliënten geëvalueerd, waarna indien nodig aanpassing volgt. Minimaal aan het begin en eind van een behandeling of minstens 1x per jaar bij langerdurende behandelingen vullen cliënten ROM-lijsten in, welke mondeling besproken worden en in het behandelplan worden opgenomen.

**13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten en/of medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:**

Minimaal iedere zes maanden, of eerder indien gewenst.

**13f. Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):**

Bij afronding van een behandeling wordt aan iedere cliënt gevraagd een digitale ROM vragenlijst in te vullen. Bij lopende behandelingen wordt in de evaluatie van het behandelplan de tevredenheid van cliënten besproken.

## **14. Afsluiting/nazorg**

**14a. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen:**

Ja

**14b. De verwijzer wordt hiervan door de regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt:**

Ja

**14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvis, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt:**

Ja

## Omgang met cliëntgegevens

### **15. Omgang met cliëntgegevens**

**15a. Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:**

Ja

**15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):**

Ja

**15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:**

Ja

## III. Ondertekening

Naam: M. Jeuken

Plaats: Bavel

Datum: 24-11-2025

**Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:**

Ja